脉管
Kaposi 肉瘤来源于血管或淋巴内皮细胞，由梭形细胞和血管构成，瘤细胞弥漫分布、实质与间质分界不清，可累及皮肤、黏膜、肺等
肉瘤共性

四、其它免疫缺陷病

先天性胸腺发育不良/DiGeorge 综合征	T 细胞缺陷 DT in the house
Bruton 综合征（X 染色体隐性遗传）	B 细胞和 γ 球蛋白（免疫球蛋白）缺陷 隐蔽
原发性重症联合免疫缺陷病	T、B 细胞缺陷
慢性肉芽肿病（感染继发）	粒细胞功能缺陷（过氧化氢产生障碍） 不能杀菌

粒细胞通过过氧化氢杀菌

五、排斥反应

1.决定排斥反应轻重：供者与受者 HLA（白细胞抗原） 的差异程度

宿主本身免疫力太差+移植物免疫力太强
2.移植物抗宿主病 GVHD：免疫功能缺陷的个体，移植物又具有大量的免疫活性细胞（骨髓、胸腺移植），移植物可针对宿主细胞产生免疫反应、导致宿主全身性组织损伤 倒反天罡

3.超急性排斥反应（移植后数分钟至数小时出现） 发生概率小,可以事先预防

①受者血液中已有供者特异性 HLA（白细胞抗原）抗体、或供者与受者 ABO 血型（红细胞抗原）不符 我准备好了

“降个级”
②广泛的急性小动脉炎（纤维素样坏死 超级变态 ttsx-变态反应太强）伴纤维素性血栓形成、缺血性坏死

只有超急性排斥反应存在　　纤维素/纤维蛋白

4.急性排斥反应（常见）

①血管型：亚急性血管炎为主（血管内膜增厚） 降个级



②细胞型：间质 CD4 和 CD8 T 细胞为主的单个核细胞浸润
VS 多个核(中性粒细胞)

5.慢性排斥反应：血管内膜纤维化 规律:慢性—纤维化

辅助T
在免疫攻击方面现认为是以体液免疫为主，而 ttsx CD4 Th 细胞发挥着关键作用：CD4 Th 细胞的活化既可诱导 CD8 CTL（细胞毒性 T 淋巴细胞）、NK 细胞和巨噬细胞活化，又可促进 B 淋巴细胞产生特异性抗体、激活补体，导致慢性排斥反应的产生
体液免疫

小凯笔记自行整理

超急性	急性血管型	慢性
纤维素样坏死	增厚	纤维化